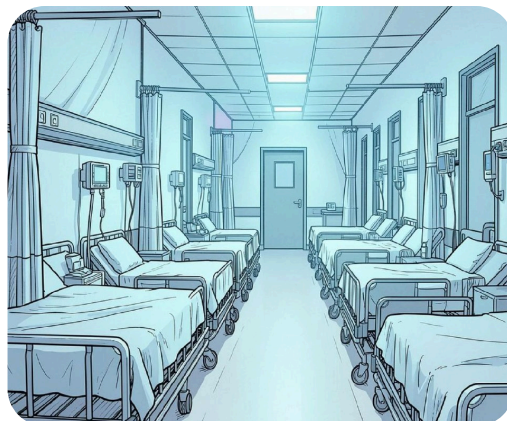


GiroSUS

Mais pacientes atendidos, sem construir nenhum leito. Quem ocupa os leitos do SUS em Goiás, por quanto tempo e quanto isso custa.



O QUE É O GIROSUS

GiroSUS é um painel de Power BI para **planejamento** da ocupação de leitos do SUS em Goiás, feito com dado oficial e mensal das internações (SIH/SUS). **Não é uma ferramenta de gestão de leitos em tempo real.**

Ele não mostra quantos leitos estão livres hoje nem onde há vaga agora. Mostra onde e quando a rede aperta, para planejar.

Usamos uma ferramenta de leito? Não. O GiroSUS não usa censo hospitalar, sistema de regulação nem cadastro de leitos: ele mede o uso do leito a partir das internações pagas pelo SUS.

O pitch

A dor

Em Goiás, falta leito e o paciente do interior espera ou é transferido. Para planejar a rede, o gestor precisa saber quem ocupa os leitos e onde o tempo de internação passa do normal.

O achado

Em 2025, **43,9% dos leitos-dia** passaram do tempo típico do procedimento.

A solução

O GiroSUS mostra quem ocupa cada leito, por quanto tempo e quanto custa, direto das internações do SUS.

O ganho

Reduzir só 10% desses dias libera **cerca de 20 mil internações por ano** (estimativa), com a mesma estrutura.

Por que confiar

Dado oficial, público e gratuito, com regras claras, testes e números conferidos.

457 mil

internações da safra 2025 em Goiás

43,9%

dos leitos-dia acima do tempo típico

~20 mil

internações a mais por ano com 10% a menos desses dias

O convite: escolher um hospital e usar o GiroSUS no próximo ciclo de planejamento.

Como lidamos com a defasagem

O SIH chega com 1 a 2 meses de atraso. O GiroSUS lida com isso em quatro camadas. Hoje o painel usa a safra 2025 fechada; as camadas marcadas como próxima etapa entram com a atualização mensal.

1 Transparência

PRÓXIMA ETAPA

O painel vai mostrar a data de corte e marcar cada mês como fechado, em consolidação ou estimado. Assim o gestor sempre sabe o que já está completo.

2 Decisão baseada em mês fechado

JÁ NO PAINEL

Os números principais, como os leitos presos além do típico e o simulador, usam a safra fechada. A defasagem não muda a decisão, só atrasa o mês mais recente.

3 Estimativa dos meses incompletos

TESTADA COM DADO REAL

O atraso da cobrança é estável: 65% das internações chegam no mesmo mês da alta e 99% em até 3 meses. Testado com 2025: no mês mais recente, erro de 8,4%, contra 29% olhando só o que chegou; um mês antes, erro de 2,7%. Entra no painel como “estimado”, com faixa de erro.

4 Atualização mensal

PRÓXIMA ETAPA

Todo mês o estimado vai virar real, e o painel vai mostrar quanto errou (o placar de acerto). Piloto: o hospital contratante pode mandar os dados dele do mês corrente para ver o “agora” dele mesmo.

E o custo? Custo estimado do mês = leitos-dia estimados × R\$ por leito-dia dos últimos 3 meses fechados, por grupo de doença. Testado com 2025: erro de 4,8% no mês mais recente. Entra no painel com a estimativa.

O que o gestor encontra no painel

Quem ocupa	Grupo de doença, diagnóstico, procedimento e cidade de origem do paciente.
Por quanto tempo	Dias de internação, faixas de duração e dias acima do tempo típico.
Quanto custa	Valor pago pelo SUS, R\$ por leito-dia e a parte da UTI.
Onde	Hospital, cidade do atendimento e quem vem de outras cidades. Goiânia tem 45% dos leitos-dia do estado, e 57% deles são de moradores de outras cidades.
Quando	Sazonalidade mês a mês por doença, com a média de internados por dia em 2025 (o que já aconteceu, não o dia de hoje): o respiratório fica 30,9% acima da média em maio.

Próximo passo: escolher um hospital, usar o GiroSUS no próximo ciclo de planejamento e ligar a atualização mensal, com a estimativa dos meses recentes e o placar de acerto.